



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · EDIÇÃO APROFUNDADA

Administração em Enfermagem

Teorias da administração · Liderança · Dimensionamento
Escalas · Avaliação de desempenho · Qualidade e indicadores

PESO MÉDIO · ALTA INCIDÊNCIA

Profa. Fátima Barbosa

COFEN 743/2024 e Parecer Normativo 1/2024 · atualizado

O eixo que virou de cabeça para baixo

Se você estudou dimensionamento pela Resolução 543/2017, precisa saber: ela foi revogada. E quase todo material de concurso ainda não sabe disso.

Este ebook cobre as teorias da administração, a liderança, o dimensionamento de pessoal, as escalas, a avaliação de desempenho e a gestão da qualidade. É o eixo onde a enfermagem deixa de ser só assistência e passa a ser **gestão do cuidado** — e onde a banca cobra tanto conceito quanto número.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Teorias da administração** — de Fayol a McGregor, e o que cada uma defende.
- ◆ **Liderança** — os estilos e o que a prova considera correto.
- ◆ **Dimensionamento** — a revogação da 543/2017 e o que vale hoje.
- ◆ **Escalas e avaliação de desempenho.**
- ◆ **Qualidade** — Donabedian, indicadores e melhoria contínua.

Nota de atualização — leia antes de tudo

Em **março de 2024**, o COFEN **revogou a Resolução 543/2017** (dimensionamento) por meio da **Resolução 743/2024**, em cumprimento a decisões judiciais. No lugar, aprovou o **Parecer Normativo nº 1/2024**. Em **2025**, a **Resolução 782/2025** trouxe o dimensionamento para dentro da **ART**.

Material que ensina a 543/2017 como norma vigente está **desatualizado**. Mas atenção: **bancas ainda cobram a 543** — e este ebook te ensina os dois cenários, com a regra para saber qual usar.

Sumário

1 Teorias da administração

Clássica, Relações Humanas

Burocracia, Contingência

Teoria X e Y

2 Liderança em enfermagem

Os estilos

Liderança situacional

O que a banca considera certo

3 Dimensionamento de pessoal

A revogação da 543/2017

O que vale hoje

Os cálculos e as siglas

4 Escalas e gestão de pessoas

Tipos de escala

Avaliação de desempenho

Educação permanente

5 Gestão da qualidade

Donabedian

Indicadores

Ciclo PDCA

6 Síntese e bizzus finais

Revisão rápida

1

Teorias da administração

Cada teoria responde a uma pergunta diferente. Saber qual é qual resolve a questão.

1 · As grandes escolas

A prova cobra autor + ideia central. Não precisa saber a teoria inteira — precisa reconhecer de quem é e o que ela defende.

● A tabela que resolve o eixo

TEORIA / AUTOR	IDEIA CENTRAL	PALAVRA-CHAVE
Administração Científica Frederick Taylor	Foco na tarefa . Estudo de tempos e movimentos, padronização, especialização do operário. O trabalhador é motivado por dinheiro (homo economicus).	TAREFA
Teoria Clássica Henri Fayol	Foco na estrutura . Hierarquia, divisão do trabalho, unidade de comando, centralização . As 4 funções: planejar, organizar, dirigir e controlar .	ESTRUTURA
Relações Humanas Elton Mayo	Foco nas pessoas . Experiência de Hawthorne: fatores emocionais e sociais afetam a produtividade. Grupos informais importam.	PESSOAS
Burocracia Max Weber	Foco nas normas . Racionalidade, impessoalidade, regras escritas, autoridade legal. A disfunção é o excesso de formalismo.	NORMAS
Teoria X e Y Douglas McGregor	DUAS visões do trabalhador. X : preguiçoso, evita responsabilidade, precisa de controle rígido. Y : motivado, criativo, busca responsabilidade.	X × Y
Contingência Fiedler / Lawrence e Lorsch	Não existe uma única maneira ideal . Tudo depende da situação e do ambiente. O estilo se adapta .	DEPENDE
Hierarquia das Necessidades Abraham Maslow	Pirâmide: fisiológicas → segurança → sociais → estima → autor-realização . Só se busca o nível seguinte após satisfazer o anterior.	PIRÂMIDE
Dois Fatores Frederick Herzberg	Higiênicos (salário, condições, chefia): evitam a insatisfação , mas não motivam. Motivacionais (reconhecimento, crescimento): esses motivam.	2 FATORES

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A linha do tempo explica tudo. Taylor e Fayol nasceram na Revolução Industrial: o problema era *produzir mais*, e o trabalhador era visto como peça da engrenagem — Taylor olhou a **tarefa**, Fayol olhou a **estrutura** da empresa inteira.

Mayo veio depois e virou a mesa: ao estudar a iluminação da fábrica de Hawthorne, descobriu que a produtividade subia *independentemente* da luz — o que mudava era o **sentir-se observado e valorizado**. Nascia a ideia de que gente não é máquina.

McGregor, Maslow e Herzberg completam: se o trabalhador não é máquina, *o que* o move? A resposta deles foi: necessidades, reconhecimento, realização — não só salário.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas clássicas: (1) atribuir a **flexibilidade** a **Fayol** — ele é o oposto, é estrutura e centralização; (2) descrever **só a Teoria X** como se fosse toda a teoria de McGregor — são **duas**, X e Y; (3) dizer que a **Contingência** defende estilo rígido — ela defende justamente que *depende*.

COMO A BANCA COBRA

“A Teoria das Relações Humanas, desenvolvida por Elton Mayo, destaca a importância dos aspectos emocionais e das relações interpessoais no ambiente de trabalho, promovendo a satisfação e o bem-estar dos profissionais.” (SELECON, 2024)

Correta. Nesta mesma questão, as erradas descreviam Fayol como flexível e descentralizado, a Contingência como autocrática e McGregor só pela visão X. **Guarde: Fayol = estrutura · Mayo = pessoas · Weber = normas · Fiedler = depende · McGregor = X e Y.**

2

Liderança em enfermagem

Chefe manda. Líder conduz. A banca sempre premia o segundo.

2 · Os estilos de liderança

Os três estilos clássicos (Kurt Lewin)

ESTILO	COMO FUNCIONA	QUANDO SERVE
Autocrático (autoritário)	O líder decide sozinho e impõe. Comunicação de cima para baixo. Gera dependência e ressentimento.	Emergência, PCR — quando não há tempo para discutir.
Democrático (participativo)	Decisões compartilhadas . O líder orienta e estimula. Gera comprometimento e satisfação.	A maioria das situações . É o preferido da banca.
Liberal (laissez-faire)	O líder não intervém . O grupo decide tudo. Pode gerar desorganização.	Equipe madura e autônoma , altamente especializada.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o autocrático não é sempre errado — e a banca sabe disso: numa PCR, ninguém vota. Alguém assume, distribui as funções e conduz. Discutir custaria a vida do paciente. O erro não é *ser* autocrático — é *ser autocrático sempre*, inclusive quando há tempo e espaço para construir junto.

É exatamente aí que entra a **liderança situacional** (Hersey e Blanchard): o estilo se ajusta à **maturidade da equipe** para aquela tarefa. Profissional novo e inseguro precisa de mais direção; profissional experiente e motivado precisa de delegação. O bom líder **troca de marcha**.

Liderança situacional — Hersey e Blanchard

MATURIDADE DA EQUIPE	ESTILO DO LÍDER
M1 — não sabe e não quer	Direção / Determinar: diz o que fazer, passo a passo.
M2 — não sabe mas quer	Orientação / Persuadir: ensina e convence.
M3 — sabe mas insegura	Apoio / Compartilhar: estimula e apoia a decisão.
M4 — sabe e quer	Delegação: entrega a responsabilidade.

BIZU ESTRATÉGICO

Regra de ouro para acertar questão de liderança: a alternativa correta quase sempre fala em **trabalho em equipe**, **decisão compartilhada**, **comunicação eficaz** e **gestão de conflitos**. As erradas trazem “**exclusivamente**”, “**sem necessidade de supervisão**”, “**imutável**”, “**irrelevante**”. Absoluto em gestão = alternativa errada.

PEGADINHA CLÁSSICA

Erro grave e recorrente: alternativa que diz que o enfermeiro **delega sem necessidade de supervisão sistemática**. Contraria o **art. 15 da Lei 7.498/86** — técnicos e auxiliares atuam **sob orientação e supervisão do enfermeiro**. Delegar não é abandonar.

3

Dimensionamento de pessoal

O tema que mudou em 2024 — e que a maioria dos materiais ainda ensina errado.

3 · O que aconteceu com a 543/2017

Resolução COFEN 743/2024 · Parecer Normativo COFEN nº 1/2024 · Resolução COFEN 782/2025

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A história — e ela cai. A Resolução 543/2017 estabelecia parâmetros *obrigatórios* de pessoal: quantas horas de enfermagem por paciente, qual a proporção de enfermeiros, quantos profissionais por leito.

Entidades do setor hospitalar privado foram à Justiça alegando que o COFEN **extrapolou sua competência**: um conselho de fiscalização profissional pode impor regras *aos profissionais*, mas não pode obrigar *instituições* a contratar — isso só por lei federal. O TRF-4 e a Justiça Federal de Goiás e do DF **suspenderam** os efeitos da norma.

Diante disso, em **março de 2024** o COFEN revogou a 543/2017 (Resolução **743/2024**) e aprovou o **Parecer Normativo nº 1/2024**, que orienta o enfermeiro sobre o *planejamento da força de trabalho* — sem impor obrigação às instituições.

● Linha do tempo do dimensionamento

NORMA	O QUE FOI
Res. 189/1996	Primeira norma de dimensionamento.
Res. 293/2004	Atualizou a anterior.
Res. 543/2017	Revogou a 293/2004. Trouxe parâmetros detalhados: horas de cuidado, SCP, IST, Constante de Marinho. REVOGADA em 2024.
Res. 743/2024	Revogou a 543/2017, por decisão judicial.
Parecer Normativo 1/2024	O que orienta hoje. Parâmetros de <i>planejamento</i> da força de trabalho pelo enfermeiro.
Res. 782/2025	Regulamenta a ART. O RT deve informar se o quadro está adequado, sub ou superdimensionado.

PEGADINHA CLÁSSICA

O que **NÃO** mudou, e a banca pode explorar: a prerrogativa do enfermeiro de **planejar, supervisionar, organizar, coordenar e avaliar** a força de trabalho continua — está na **Lei 7.498/86**, não na resolução. E a própria lei já determina que a instituição tenha profissionais em número suficiente, e que **paciente grave com risco de vida receba assistência direta do enfermeiro**.

Ou seja: caiu a *tabela*, não caiu a *responsabilidade*.

COMO A BANCA COBRA

Como responder quando a questão citar dimensionamento?

- Se o enunciado **citar a Resolução 543/2017** → responda pela redação dela (a banca está cobrando o texto, mesmo revogado).
- Se disser “**norma vigente**” ou for prova de 2025/2026 → a 543 **está revogada**; vale o **Parecer Normativo 1/2024**.
- Se a alternativa disser que a **543 está em vigor** → **errada**.

3 · Os conceitos e as siglas

Mesmo com a revogação, os **conceitos técnicos** continuam sendo cobrados — e o Parecer Normativo os mantém como referência de planejamento.



As siglas que caem

SIGLA	O QUE É
SCP	Sistema de Classificação de Pacientes. Classifica o paciente pelo grau de dependência da enfermagem. Instrumento mais usado: Escala de Fugulin .
THE	Total de Horas de Enfermagem. Somatório das horas necessárias para assistir todos os pacientes.
IST	Índice de Segurança Técnica. Percentual acrescido ao quadro para cobrir férias, folgas, faltas e licenças. Mínimo de 15% .
KM	Constante de Marinho. Usada no cálculo do quantitativo de pessoal, relaciona dias da semana, jornada e IST.
QP	Quadro de Profissionais. O resultado final do cálculo.

Horas de cuidado por grau de dependência (Res. 543/2017 — referência)

GRAU DE DEPENDÊNCIA	HORAS DE ENFERMAGEM / PACIENTE / 24H	QUEM ASSISTE
Cuidado mínimo	4 horas	Paciente autossuficiente
Cuidado intermediário	6 horas	Recuperação, parcialmente dependente
Alta dependência	10 horas	Crônico, dependente, mas estável
Cuidado semi-intensivo	10 horas	Risco de instabilidade
Cuidado intensivo	18 horas	Grave, risco iminente de morte

BIZU ESTRATÉGICO

Mnemônico das horas: 4 → 6 → 10 → 10 → 18. Repare que **alta dependência** e **semi-intensivo** têm o **MESMO** valor (10h) — a diferença é que o de alta dependência é *crônico e estável*, e o semi-intensivo tem *risco de instabilidade*. E a proporção de enfermeiros sobe com a complexidade: no **intensivo**, 52% a 56% do quadro deve ser de enfermeiros.

Atenção: esses parâmetros são da 543/2017, hoje revogada. Continuam sendo referência técnica e ainda caem em prova — mas não como “norma obrigatória vigente”.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o IST existe — e por que 15% é o mínimo: se você dimensionar exatamente o número de profissionais necessários para cobrir os leitos, o serviço quebra no primeiro dia de férias. O IST é a **gordura técnica** que cobre o previsível (férias, folgas) e o imprevisível (faltas, licenças). Sem ele, o dimensionamento é ficção.

Na mesma lógica, a 543 previa: **+5%** do quadro geral para rotatividade e educação permanente, e **+10%** quando 50% ou mais da equipe tem mais de 50 anos (ou 20% tem restrição). Gestão de gente real, não de planilha.

4

Escalas e gestão de pessoas

Escala é instrumento de gestão — não é lista de nomes.

4 · Tipos de escala

● As escalas do serviço de enfermagem

ESCALA	PARA QUE SERVE
Mensal	Distribui os profissionais nos turnos ao longo do mês. Prevê folgas e cobertura.
Diária	Distribui os profissionais daquele plantão entre pacientes e atividades.
De férias	Planejamento anual, respeitando a legislação trabalhista.
Educativa	Programação de treinamentos e educação permanente .

BIZU ESTRATÉGICO

A elaboração da escala é **atribuição do enfermeiro** e deve considerar: grau de dependência dos pacientes, competência de cada profissional, legislação trabalhista, e — o ponto que a banca cobra — as **necessidades individuais** da equipe. Alternativa que diz que a escala é “fixa e imutável” está errada.

4 · Avaliação de desempenho

É atribuição do enfermeiro gerente. Serve ao **desenvolvimento** profissional, não à punição.

● Como avaliar

ASPECTO	COMO DEVE SER
Critérios	Objetivos (indicadores, metas, cumprimento de protocolo) e subjetivos (postura, relacionamento, iniciativa).
Finalidade	Desenvolvimento profissional e melhoria da assistência — nunca punição .
Retorno	Feedback construtivo, individual e contínuo — não só na avaliação anual.
Erro comum	Efeito halo : deixar que uma característica marcante (boa ou ruim) contamine toda a avaliação.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que só critério objetivo não basta: dois técnicos podem ter o mesmo número de procedimentos e o mesmo cumprimento de checklist — e um deles ser o que a equipe procura quando algo dá errado, enquanto o outro é o que ninguém quer de dupla. Isso não aparece em planilha, mas é *desempenho*. Daí a avaliação combinar os dois olhares.

5

Gestão da qualidade

Donabedian e o PDCA. Dois nomes, muitas questões.

5 · A tríade de Donabedian

É o modelo clássico de avaliação da qualidade em saúde — e cai em quase toda prova que toca em qualidade.

A tríade de Donabedian

DIMENSÃO	O QUE AVALIA	EXEMPLO
Estrutura	Os recursos: instalações, equipamentos, materiais, número e qualificação de pessoal , financiamento.	Nº de leitos · quadro de enfermeiros · autoclave disponível
Processo	O que é feito : as atividades, a técnica, a relação profissional-paciente.	Adesão à higiene das mãos · aplicação do checklist · SAE implantada
Resultado	O efeito sobre a saúde: desfechos, satisfação.	Taxa de infecção · mortalidade · satisfação do usuário · LPP

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A tríade tem uma lógica de **causa e efeito**: boa *estrutura* aumenta a chance de bom *processo*, que aumenta a chance de bom *resultado*. Mas não garante — hospital com equipamento de ponta e equipe que não higieniza as mãos tem estrutura excelente e resultado péssimo.

É por isso que se avaliam os **três**. Medir só resultado não diz *onde* consertar; medir só estrutura não diz se ela está sendo *usada*.

BIZU ESTRATÉGICO

Como classificar rápido: **tem?** é **estrutura** (recurso). **Faz?** é **processo** (ação). **Deu certo?** é **resultado** (desfecho). Taxa de infecção é *resultado*; adesão à higiene das mãos é *processo*; número de pias é *estrutura*.

5 · Indicadores e PDCA

Indicadores de enfermagem que caem

INDICADOR	O QUE MEDE
Incidência de LPP	Lesão por pressão — indicador sensível à enfermagem por excelência.
Incidência de queda	Segurança do paciente. Evento sentinela.
Incidência de flebite	Qualidade do cuidado com acesso venoso.
Taxa de absenteísmo	Gestão de pessoas. Ausências não previstas.
Taxa de rotatividade (turnover)	Entradas e saídas de profissionais. Alta rotatividade = alerta de gestão.
Taxa de ocupação	Leitos ocupados sobre leitos disponíveis.

BIZU ESTRATÉGICO

LPP, queda e flebite são os três indicadores mais associados diretamente à qualidade da assistência de enfermagem — por isso são os prediletos da banca. Se a questão pedir “indicador sensível à enfermagem”, olhe para eles.

Ciclo PDCA — a melhoria contínua

ETAPA	O QUE SE FAZ
P — Plan (planejar)	Identificar o problema, analisar a causa, definir metas e o plano de ação.
D — Do (fazer)	Executar o plano, treinar e coletar dados.
C — Check (checar)	Verificar os resultados contra a meta.
A — Act (agir)	Padronizar o que deu certo ou recomeçar o ciclo se não deu.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O PDCA é um **ciclo**, não uma linha — e é aí que mora a questão. O “A” não é o fim: ou você *padroniza* a melhoria (e ela vira o novo normal), ou *reinicia* o ciclo com o que aprendeu. Qualidade não tem linha de chegada.

6

Síntese

As trocas e os nomes que decidem a questão.

6 · Revisão rápida do eixo

● Colinha final — autor e ideia

AUTOR	GUARDE ASSIM
Taylor	TAREFA — tempos e movimentos
Fayol	ESTRUTURA — planejar, organizar, dirigir, controlar
Mayo	PESSOAS — Hawthorne, fatores emocionais
Weber	NORMAS — burocracia, impessoalidade
McGregor	X (pessimista) e Y (otimista) — são DUAS
Fiedler	DEPENDE — contingência
Maslow	PIRÂMIDE de necessidades
Herzberg	HIGIÊNICOS (não motivam) × MOTIVACIONAIS
Donabedian	ESTRUTURA · PROCESSO · RESULTADO
Hersey e Blanchard	SITUACIONAL — M1 a M4

DIMENSIONAMENTO — O ESSENCIAL

- ◆ **543/2017 foi REVOGADA** pela **743/2024**, por decisão judicial.
- ◆ Hoje orienta o **Parecer Normativo nº 1/2024**; a **782/2025** ligou o dimensionamento à **ART**.
- ◆ Caiu a tabela obrigatória — **não** caiu a prerrogativa do enfermeiro (Lei 7.498/86).
- ◆ Horas de cuidado (referência): **4 · 6 · 10 · 10 · 18**. IST mínimo: **15%**.
- ◆ SCP = classifica dependência (Fugulin) · THE = total de horas · KM = Constante de Marinho.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs do eixo: (1) Fayol descrito como flexível; (2) McGregor reduzido só à Teoria X; (3) Contingência apresentada como rígida; (4) dizer que a **543/2017** **está vigente**; (5) delegar **sem supervisão**; (6) escala “fixa e imutável”; (7) confundir **processo** com **resultado** em Donabedian. Domine essas sete e o eixo é seu.

“Gerenciar enfermagem não é preencher escala. É garantir que exista gente suficiente para cuidar com segurança.”

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM

Conteúdo conferido nas fontes oficiais: Lei nº 7.498/86, Resolução COFEN nº 743/2024 (que revogou a 543/2017), Parecer Normativo COFEN nº 1/2024, Resolução COFEN nº 782/2025 e Nota Oficial do COFEN de 18/03/2024. O cenário normativo do dimensionamento segue em disputa judicial e legislativa (PLS 448/2016) — confirme a situação vigente antes da prova.